

Datos Personales							
Nombre:	ATY NAYUREWA LENS MUELAS	Sexo Biológ.:	M	F. Nacimiento:	2015-09-28	Edad	10 Años, 4 Meses, Y 20 Días
Identificación:	TI - 1150188051	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	ESTUDIANTE
Correo Electrónico:	Dunen@hotmail.Com - 1150188051			Dirección:	CL 5A KR 19E - 8 CASA 6, Dundakare		
Departamento:	CESAR		Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana
Empresa:	EPS010 - (EPS SURA)						
En Caso De Emergencia Llamar A:		DUNEN KANEYBIA MUELAS IZQUIERDO - Parentesco (madre) - Teléfono (3182575411)					

Apertura psicología del 2026-02-17 12:16:04: 10 años, 4 meses, y 20 días

DATOS GENERALES

Remisión

AUTORREFERIDO - SURA Medicina Prepagada

DX principal

NREF - NO REFIERE

DX Relacionado 1

NREF - NO REFIERE

DX Relacionado 2

NREF - NO REFIERE

Código de consulta

890208 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA

Motivo de Consulta

Refiere la madre, “Aty es mi hija mayor tiene 10 años, es tímida, tranquila, me preocupa de ella su autonomía, su inconstancia, no quiero estar detrás de ella” , “le digo que vamos a leer dice que le da pereza, quiero que sea independiente porque le mando hacer cosas y me dice que no”, "En cuanto a salud es muy saludable, muy básica al cambiarse, descuidada, se pone los zapatos sucios, las pantis sucias".

Enfermedad Actual

Paciente femenina llevada a consulta por la madre, quien refiere dificultades en el área emocional, conductual y adaptativa. Aty es la hija mayor; tiene dos hermanos menores por parte de la relación actual de la madre, establecida desde hace aproximadamente cinco años. La paciente convivió con su padre biológico hasta los 3 años de edad.

La madre refiere antecedentes de dificultades en el rendimiento escolar desde la etapa en que residían en Bogotá, donde docentes reportaban bajo desempeño académico. Describe a la paciente como reservada, con tendencia al retraimiento social. Señala que la menor ha manifestado sentimientos de desplazamiento dentro del sistema familiar, al percibir que sus hermanos cuentan con mayor red familiar extensa. Refiere además que el padrastro mantiene una relación distante, percibida como respetuosa pero poco cercana. En el área del sueño, la paciente presenta dificultad para dormir sola, compartiendo habitación con hermanos y cuidadora por miedo nocturno. A nivel conductual, la madre reporta desorganización, baja iniciativa frente a demandas académicas y domésticas, irritabilidad y fatiga ante tareas múltiples. Se observa baja tolerancia a la frustración, especialmente cuando percibe presión externa, con tendencia a evitación y somatización (dolor abdominal) ante situaciones demandantes.

En la historia alimentaria temprana se describen patrones restrictivos; durante etapa preescolar requería uso de pantallas para alimentarse y presentó selectividad alimentaria marcada (por ejemplo, consumo repetitivo de huevo con bebidas achocolatadas entre los 3 y 4 años), lo cual requirió intervención progresiva para ampliar repertorio alimentario.La madre refiere presencia de temores diversos, incluyendo miedo a hablar en público, salir sola y fobias específicas (ej. al mar). En cuanto a salud física general, la describe como médicamente sana.A nivel adaptativo, reporta dificultades en hábitos de autocuidado, describiéndola como descuidada en su presentación personal (uso de ropa o calzado sucio), con baja supervisión interna en hábitos de higiene y organización.

ANTECEDENTES

Médicos Personales

Quirúrgico

No Refiere

Traumáticos

Ninguno

Paraclínicos

No Refiere

Patología

No Refiere

Tóxicos

Medicación

No Refiere

Hospitalizaciones

No Refiere

ANTECEDENTES

Prenatales

Edad De La Madre En El Embarazo 23 Años	Enfermedades De La Madre No
Único Embarazo Primer	El Embarazo Fue Controlado Por Atención Médica Si
Uso De Planificación En El Momento Del Embarazo No	Estado De La Madre Durante El Embarazo Regulado

ANTECEDENTES

Natales

Tipo De Nacimiento Natural	Causa De La Cesárea NA
Uso De Maniobras De Reanimación No	Peso Al Nacer No Refiere
Talla Al Nacer No Refiere	Llanto Al Nacer Si

ANTECEDENTES

Posnatales

Hospitalizaciones Recién Nacido No Refiere
--

ANTECEDENTES

Desarrollo Psicomotor

Control Cefálico 2M	Rolado 3M
Sedente Solo 4M	Gateo 7M
Bípodo Sin Ayuda 8M	Marcha 12M
Lenguaje Verbal 18M	Lenguaje Verbal Fluido 24M

ANTECEDENTES

Médicos Familiares

Depresión Abuela Paterna	Ansiedad No Refiere
Demencia No Refiere	Alcoholismo No Refiere
Drogadicción No Refiere	Discapacidad Intelectual No Refiere
Patológicos No Refiere	Otros No Refiere

Áreas de Ajuste y/o Desempeño

Historia educativa Actualmente la paciente cursa grado séptimo en el colegio Gimnorte. Según refiere la madre, presenta desempeño académico global adecuado, sin reportes recientes de dificultades significativas en el ámbito escolar. Se evidencian preferencias académicas definidas, con menor afinidad hacia áreas lógico-matemáticas (especialmente matemáticas y geometría) y mayor interés por asignaturas artísticas. Se describe adecuada adaptación al entorno escolar, con relaciones interpersonales funcionales con pares. No se reportan dificultades relevantes en convivencia escolar al momento de la valoración.
Historia laboral Actualmente la paciente no participa en actividades deportivas estructuradas. No obstante, manifiesta interés en la práctica de disciplinas como patinaje y natación. Se sugiere considerar la vinculación progresiva a actividades físicas recreativas, dado su potencial beneficio en regulación emocional, fortalecimiento de habilidades sociales y promoción de hábitos saludables.
Historia familiar La paciente convive actualmente con su madre Dunen Muelas (33 años), su padrastro Duiruney Torres (30 años) y dos hermanos menores, Sen de 3 años y Nuwun de 1 año de edad, respectivamente. Según refiere la madre, el núcleo familiar ha alcanzado una dinámica relativamente estable, en la cual la paciente se percibe segura en términos generales. No obstante, se

reportan indicadores de posible vivencia subjetiva de desplazamiento dentro del sistema familiar, manifestados a través de conductas de retraimiento, silencios prolongados o episodios ocasionales de irritabilidad ante situaciones propias del entorno doméstico. Estas manifestaciones sugieren dificultades en la expresión emocional y en la adaptación a los cambios estructurales del sistema familiar.

Historia social

Durante la etapa de educación inicial (jardín), se reportaron conductas socialmente inapropiadas, sin mayor especificación en el momento actual. En la actualidad, la paciente presenta evolución favorable en el área social, evidenciándose mayor integración con pares. Se describe interacción funcional con compañeras de su edad y familiares cercanas (primas), mostrando disposición a participar en actividades grupales cuando percibe un entorno de seguridad y confianza. La vinculación social parece estar mediada por niveles de ansiedad social o inhibición conductual, con mejor desempeño en contextos conocidos y con figuras significativas.

Historia emocional/afectiva

Durante la etapa de educación inicial (jardín), la paciente presentó dificultades en la regulación emocional, las cuales motivaron proceso de acompañamiento psicológico enfocado en el manejo de emociones. En la actualidad, la madre describe variabilidad en el estado emocional. En algunos momentos se muestra tranquila; sin embargo, presenta episodios de irritabilidad y reactividad emocional ante demandas externas o situaciones que percibe como exigentes. Se describe alta sensibilidad emocional, con tendencia al llanto fácil y fluctuaciones rápidas en el estado afectivo, logrando posteriormente retornar a la calma en intervalos relativamente cortos. Este patrón sugiere dificultades en la regulación emocional, con predominio de respuestas afectivas intensas y transitorias ante estímulos percibidos como estresores.

Historia deportiva

Actualmente la paciente no participa en actividades deportivas estructuradas. No obstante, manifiesta interés en vincularse a disciplinas como patinaje y natación. Se sugiere considerar la inclusión progresiva en actividades físicas recreativas, dado su potencial impacto positivo en la regulación emocional, fortalecimiento de habilidades sociales y promoción de hábitos saludables.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Evaluación psicológica inicial

Se aplicó entrevista semiestructurada enfocada en valorar las áreas de ajuste personal, social y emocional, así como la red de apoyo cercana, con el fin de explorar la percepción de la paciente en contextos extrafamiliares, identificar recursos adaptativos y comprender su funcionamiento en escenarios escolares y sociales. Esta técnica permitió complementar la información obtenida por el acudiente y contrastar la vivencia subjetiva de la menor con su desempeño en diferentes entornos.

También se aplicó el Test de la Familia como técnica proyectiva gráfica con el objetivo de explorar la percepción subjetiva del sistema familiar, vínculos afectivos y posicionamiento emocional de la paciente dentro del núcleo familiar. El Test de la Familia evidencia representación nuclear con predominio del vínculo materno, omisión de hermanos convivientes y ubicación intermedia del yo, sugiriendo necesidad de pertenencia y posibles vivencias subjetivas de desplazamiento afectivo. El estilo gráfico y narrativo es compatible con perfil emocional sensible, con tendencia a la internalización y mecanismos de idealización vincular.

Por último se aplicó la Escala de Ansiedad Infantil de Spence como instrumento de tamizaje para sintomatología ansiosa en población infantil. La paciente obtuvo un puntaje total de **48 puntos**, ubicándose en un rango compatible con **ansiedad moderada**. El análisis cualitativo de las respuestas evidencia predominio de preocupaciones anticipatorias, temores relacionados con daño a figuras significativas, ansiedad de desempeño y miedos evolutivos específicos. Asimismo, se identifican indicadores de inseguridad emocional y tendencia a la rumiación ansiosa, sin presencia de síntomas de pánico estructurado ni rasgos obsesivo-compulsivos clínicamente significativos.

Los hallazgos se consideran coherentes con el contexto evolutivo y familiar descrito, sugiriendo un perfil ansioso de predominio internalizante, que requiere abordaje psicoterapéutico preventivo y fortalecimiento de recursos de regulación emocional.

El análisis integrado de la entrevista clínica, evaluación conductual, técnicas proyectivas y aplicación de la Escala de Ansiedad Infantil de Spence evidencia un perfil emocional caracterizado por sintomatología ansiosa de intensidad moderada, con predominio de preocupaciones anticipatorias, sensibilidad emocional elevada y temores relacionados con la seguridad de figuras significativas. La sintomatología se presenta en el contexto de cambios en la dinámica familiar y demandas evolutivas propias de la etapa, sin evidenciar deterioro funcional significativo ni criterios para trastornos de ansiedad estructurados.

El cuadro es compatible con dificultades adaptativas con predominio ansioso, en el marco de un funcionamiento global conservado y adecuada capacidad de insight emocional para la edad.

Interconsultas e Intervenciones

Intervención psiquiátrica

No refiere

Intervención neurológica

No refiere

Intervención neuropsicológica

No refiere

Otras intervenciones

Inicio proceso con Psicología, donde logro asistir a dos sesiones en la ciudad de Bogotá. Se interrumpió el proceso y decidieron retomar en la ciudad de valledupar actualmente.

EXAMEN MENTAL

Examen Mental

Paciente que ingresa a consulta con adecuado saludo inicial y actitud respetuosa. Presenta apariencia acorde a la edad y al contexto, con vestimenta adecuada. Se observa actitud tímida, con contacto visual intermitente y tono de voz bajo. Se encuentra orientada auto y alopsiquicamente. El lenguaje es coherente, organizado y acorde al nivel evolutivo, con discurso comprensible y contenido pertinente. Se evidencia atención sostenida durante la entrevista, con adecuada capacidad de seguimiento de instrucciones. El pensamiento se caracteriza por curso lógico y asociación adecuada de ideas. No se evidencian alteraciones formales del pensamiento ni contenidos delirantes. La inteligencia se aprecia clínicamente conservada, acorde a la edad y escolaridad.

A nivel afectivo, se observa tonalidad ansiosa leve con rasgos de inhibición conductual, sin labilidad marcada durante la evaluación. Se muestra participativa cuando se le brinda contención, logrando expresar opiniones de manera progresiva. No se identifican ideas suicidas ni autolesivas. Niega alteraciones sensorceptivas; no se evidencian alucinaciones ni fenómenos de despersonalización o desrealización durante la valoración. No se observan indicadores de riesgo psicológico agudo.Se encuentra vigil, alerta y colaboradora. Comprende las consignas dadas y mantiene adecuada disposición frente al proceso de entrevista y evaluación psicológica.

Ciclos del Sueño

Conservados

Apetito

Conservado

Actividades de Autocuidado

Actualmente la paciente se encuentra en proceso de adquisición y fortalecimiento de rutinas relacionadas con hábitos de autocuidado y organización personal. Se evidencia necesidad de acompañamiento en la estructuración de hábitos saludables acordes a su etapa evolutiva.

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Impresión Diagnóstica (CIE 10 - DSM-V):
F432 - TRASTORNOS DE ADAPTACION
Impresión Diagnóstica Relacionada 1
F43.22 - TRASTORNO DE ADAPTACIÓN, CON ANSIEDAD
Impresión Diagnóstica Relacionada 2
NREF - NO REFIERE

Establecido por primera vez
Si

Objeto de atención clínica
No REFIERE

PLAN DE INTERVENCIÓN

Plan de Intervención

Objetivo General
Fortalecer las habilidades de regulación emocional, seguridad personal y adaptación socioafectiva de la paciente, promoviendo el desarrollo de recursos internos que favorezcan su bienestar psicológico, la expresión emocional adecuada y la consolidación de vínculos familiares y sociales más seguros.

- Objetivos Específicos**
- Fortalecer habilidades de identificación y expresión emocional, favoreciendo la comunicación asertiva de necesidades y estados afectivos.
 - Desarrollar estrategias de regulación emocional que permitan mejorar la tolerancia a la frustración y disminuir reacciones de irritabilidad ante demandas externas.
 - Abordar posibles vivencias subjetivas de desplazamiento dentro del sistema familiar, promoviendo el fortalecimiento del autoconcepto y la seguridad emocional.
 - Favorecer habilidades sociales y confianza en contextos extrafamiliares, reduciendo indicadores de inhibición social.
 - Acompañar a la madre mediante orientación psicoeducativa, brindando herramientas para manejo emocional, validación afectiva y fortalecimiento del vínculo.
 - Promover hábitos adaptativos relacionados con autonomía personal, organización y autocuidado acordes a la etapa evolutiva.

Sugerencias e Interconsultas
No se consideran remisiones a otros especialistas en el momento actual. Se sugiere manejo inicial desde psicología clínica, con seguimiento evolutivo y valoración interdisciplinaria en caso de identificarse nuevas necesidades clínicas.

Observaciones y Recomendaciones
OBSERVACIONES
Durante el proceso de valoración, la paciente se mostró colaboradora y con adecuada disposición al vínculo terapéutico. Se evidencian recursos comunicativos acordes a la edad y capacidad de introspección en desarrollo. No se observaron indicadores de riesgo psicológico agudo al momento de la evaluación.
La información obtenida mediante entrevista clínica y técnicas proyectivas resulta coherente entre sí, permitiendo una comprensión integral del funcionamiento emocional y relacional de la paciente. Se sugiere seguimiento psicológico para profundizar en el fortalecimiento de habilidades socioemocionales y acompañar su proceso evolutivo.

- RECOMENDACIONES
- Iniciar proceso psicoterapéutico con frecuencia semanal, orientado a fortalecimiento emocional y habilidades socioafectivas.
 - Favorecer espacios individuales madre-hija que refuercen la validación emocional y el sentido de pertenencia.
 - Evitar estilos de crianza basados en presión o sobreexigencia emocional, promoviendo acompañamiento empático y estructuración gradual de normas.
 - Incentivar la vinculación a actividades extracurriculares de interés (ej. patinaje o natación, voleibol), como estrategia de fortalecimiento emocional y social.
 - Mantener comunicación y articulación con el entorno escolar para monitoreo del ajuste socioemocional.
 - Promover rutinas estructuradas que favorezcan hábitos de organización, autonomía y autocuidado. (Planeador, economía de fichas, tecnica POMODORO)

DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica
Tarjeta Profesional: 259542
Mag. TP3G - VIU